AULA CLÍNICA — SEMIOLOGÍA I

Manual de sistema digestivo

La unidad que el profesor define como una de las más preguntadas en parciales y finales: motivos de consulta, examen físico, síndromes del tubo digestivo, hígado, páncreas, vías biliares y emergencias.

- Disfagia, dispepsia, náuseas y vómitos

Versión del 7 de noviembre de 2026 · 1 capítulo publicado · Material original elaborado a partir de las clases del Dr. Ortega y su libro de Clínica Médica I.

CAPÍTULO 1

Disfagia, dispepsia, náuseas y vómitos

Los motivos de consulta del tubo digestivo alto: cómo ubicar el nivel de la lesión y el mecanismo a partir de lo que cuenta el paciente.

NECESITÁS SABER

- Anatomía del tubo digestivo alto
- Fisiología de la deglución
- Semiología del dolor (1.er parcial)
- Agua, electrolitos y ácido-base

Motivos de consulta del tubo digestivo alto

Son las formas en que el trayecto boca → esófago → estómago → duodeno avisa que algo falla. Bien interrogados, permiten ubicar **dónde** está el problema y **qué mecanismo** lo produce antes de pedir un solo estudio.

Disfagia
¿Dónde se traba? Orofaríngea vs esofágica · ¿Con qué alimento? Mecánica vs motora · Algoritmo y estudios

Dispepsia
Criterios de Roma · Orgánica (40 %) vs funcional (60 %) · Clínica "2 D + P" y signos de alarma

Náuseas y vómitos
Vómito, regurgitación y rumiación · Qué contiene y cuándo aparece · Contexto y laboratorio

Cuándo preocuparse
Alcalosis hipopotasémica y deshidratación · Mallory-Weiss y Boerhaave · Signos de alarma → endoscopía

AL TERMINAR VAS A PODER

- Distinguir una disfagia orofaríngea de una esofágica con tres preguntas.
- Separar la disfagia mecánica de la motora y orientar acalasia, estenosis péptica o cáncer.
- Definir la dispepsia con criterios de Roma y reconocer los signos de alarma que obligan a una endoscopía.
- Leer un vómito por su contenido y su horario, y anticipar sus complicaciones.

El trayecto: de la boca al duodeno

MUY IMPORTANTE

> Cada motivo de consulta de este capítulo corresponde a un tramo del recorrido. Ubicar el tramo es el primer paso del razonamiento.



Los anillos marcan esfínteres. Náuseas y vómitos pueden originarse en cualquier tramo… o fuera del tubo digestivo.

Esquema propio del tubo digestivo alto. A la izquierda, el tramo donde se origina cada motivo de consulta.

Tercio superior del esófago

Músculo **estriado**: lo afectan las enfermedades neuromusculares (ACV, miastenia, miopatías). Por eso dan disfagia **alta**.

Dos tercios inferiores

Músculo **liso** con plexo mientérico (Auerbach) y control **vagal**: allí asientan la acalasia, el espasmo difuso y la esclerodermia.

Esfínteres

El **superior** (cricofaríngeo) y el **inferior** se relajan en el momento justo. Si no lo hacen, el bolo se detiene antes de ellos.

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL

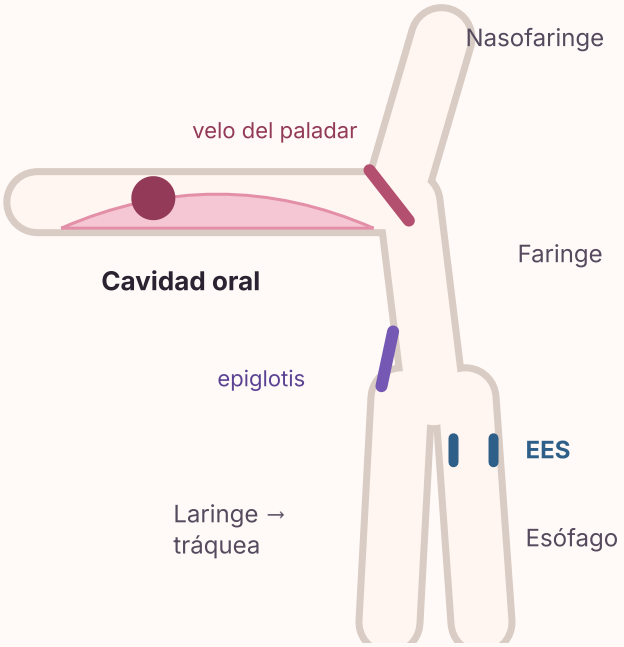
La distribución estriado/liso del músculo esofágico es anatomía general; se incluye porque explica por qué el profesor agrupa las causas de disfagia orofaríngea como “neuromusculares”.

Cómo tragamos: una fase voluntaria y dos involuntarias

IMPRESCINDIBLE

> El profesor arranca el tema por acá: si sabés qué pasa en cada fase, sabés qué síntoma aparece cuando falla.

Tragar es transferir el alimento desde la boca hasta el estómago en dos tramos: de la boca a la parte superior del esófago, y del esófago al estómago. Intervienen **tres mecanismos**: **uno voluntario** —la masticación, con los músculos masticadores y la lengua— y **dos involuntarios** —faríngeo y esofágico—, comandados por el sistema nervioso autónomo, sobre todo el **parasimpático**, que aumenta el peristaltismo.



1. Fase oral • Voluntaria

Los músculos masticadores y la lengua trituran el alimento, forman el bolo y lo empujan hacia la faringe.

Si falla: cuesta formar y propulsar el bolo: el paciente "no puede arrancar" a tragar.

2. Fase faríngea • Involuntaria (refleja, ~1 segundo)

El velo del paladar cierra la nasofaringe, la laringe se eleva, la epiglotis tapa la vía aérea (apnea deglutoria) y se relaja el esfínter esofágico superior.

Si falla: el bolo va a la nariz (regurgitación nasal) o a la vía aérea (tos, ahogo, disfonía, neumonía aspirativa): disfagia orofaríngea.

3. Fase esofágica • Involuntaria (parasimpático / vago)

Una onda peristáltica recorre el esófago; el esfínter esofágico inferior se relaja al llegar la onda y el bolo entra al estómago.

Si falla: ante un obstáculo o una peristalsis defectuosa, el bolo se detiene detrás del esternón: disfagia esofágica.

Tocá cada fase o animá la secuencia: el velo del paladar cierra la nariz, la epiglotis tapa la vía aérea y el esfínter esofágico superior se abre.

DEL MECANISMO AL SÍNTOMA

CAUSA
Lesión neurológica o muscular (p. ej., ACV)

→

MECANISMO
Fallan el cierre de la nasofaringe y de la vía aérea

→

MANIFESTACIÓN
Regurgitación nasal, tos, ahogo, neumonía aspirativa

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Uno de los tres mecanismos es voluntario (la masticación) y dos son involuntarios; todo el tramo faringe–esófago–estómago es involuntario y depende del sistema autónomo, sobre todo del parasimpático.

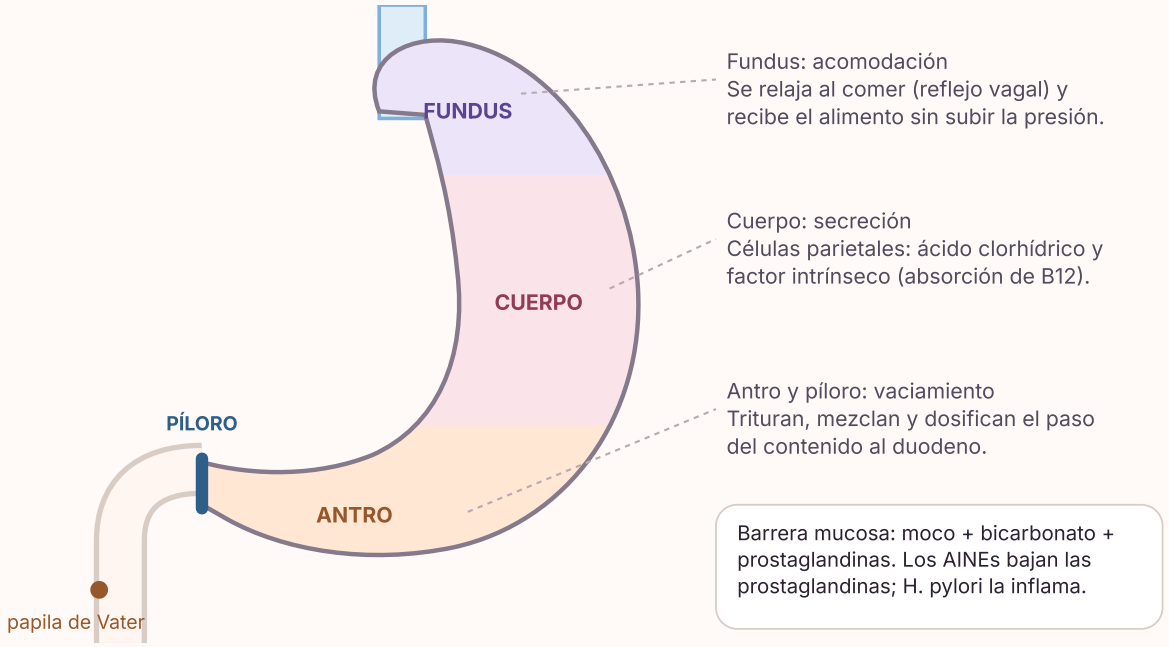
FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 01:33 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 02:20

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 00:49 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 01:33

El estómago: acomodar, secretar, vaciar y protegerse

MUY IMPORTANTE

> La dispepsia funcional se entiende como una falla de estas funciones normales, no como una lesión visible.



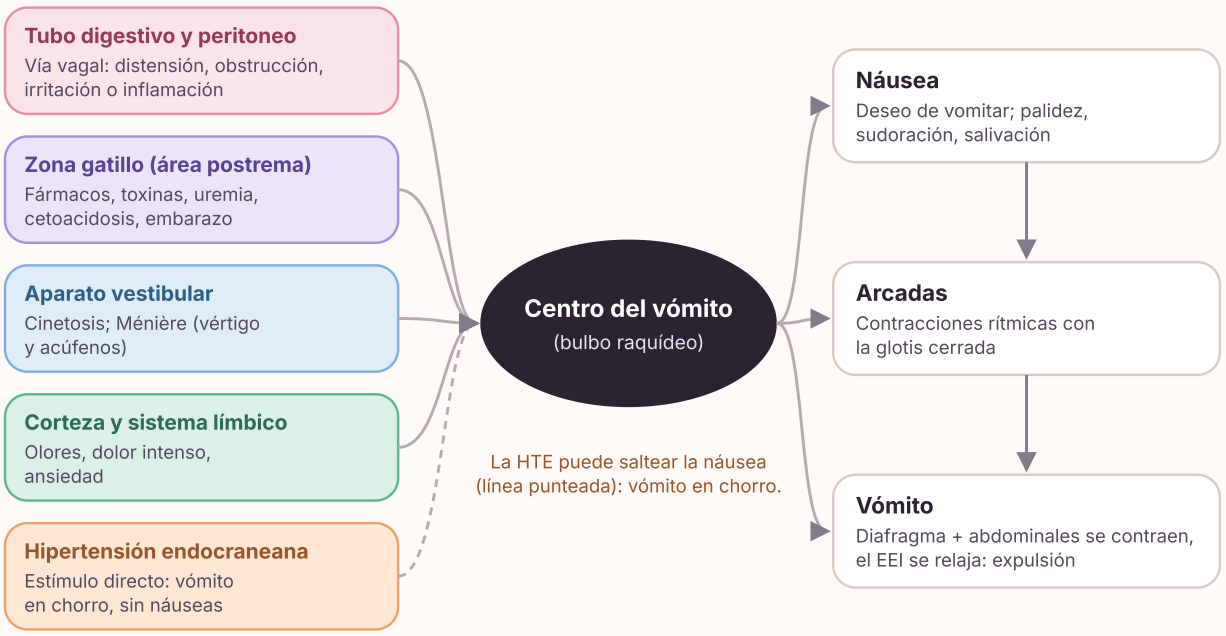
Cada región tiene una función; la dispepsia aparece cuando el fundus no acomoda, el antro vacía lento o la mucosa se vuelve hipersensible.

- **Acomodación fúndica**: al comer, el fundus se relaja por un reflejo vagal y recibe el alimento sin que suba la presión. Si falla → plenitud y saciedad precoz.
- **Secreción**: las células parietales del cuerpo producen ácido clorhídrico y factor intrínseco (necesario para absorber la vitamina B12 en el íleon terminal).
- **Vaciamiento**: el antro tritura y el píloro dosifica el paso al duodeno. Si se enlentece, el contenido queda retenido.
- **Barrera mucosa**: moco, bicarbonato y prostaglandinas. Los AINEs inhiben las prostaglandinas; *Helicobacter pylori* inflama la mucosa.

El reflejo del vómito

MUY IMPORTANTE

> El vómito es una respuesta del sistema nervioso, no solo del estómago. Por eso sus causas están repartidas por todo el organismo.



Cinco vías llegan al centro del vómito; la secuencia de salida es náusea → arcadas → vómito.

Esto explica por qué el profesor insiste en que el vómito "puede ser del sistema nervioso, del digestivo, cardíaco, urinario, fisiológico —por el embarazo— o por fármacos": cualquiera de esas vías puede estimular el centro del vómito.

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL

La organización del reflejo (centro bulbar, zona gatillo quimiorreceptora del área postrema, aferencias vagales y vestibulares) es fisiología general, agregada para entender la clasificación de causas que da la clase.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 25:17

Disfagia: qué es y cómo se clasifica

IMPRESCINDIBLE

> Disfagia significa "dificultad para comer". La primera gran división depende de en qué tramo falla el pasaje del bolo.

POR QUÉ IMPORTA ESTA UNIDAD

El profesor presenta el aparato digestivo como una de las unidades más preguntadas, en el parcial y sobre todo en los finales, con muchas preguntas de clasificaciones y diagnósticos.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 00:00

Disfagia

Dificultad para el pasaje del alimento desde la boca hasta el estómago. Puede responder a una causa orgánica y, por lo tanto, **nunca debe desestimarse**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 00:49

Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 368

LA PRIMERA PREGUNTA: ¿EN QUÉ TRAMO FALLA?

Orofaríngea

- También llamada **alta** o **de transferencia**.
- Falla el pasaje de la boca a la parte superior del esófago.
- El paciente no logra **iniciar** la deglución.

Esofágica

- También llamada **baja** o **de transporte**.
- Falla el transporte por el cuerpo esofágico o el esfínter inferior.
- Traga bien y **después** se le atasca.

¿Por qué “de transferencia”? Porque lo que falla es la transferencia del bolo desde la cavidad oral hacia la faringe. ¿Por qué “de transporte”? Porque el bolo ya entró al esófago, pero no logra ser transportado hasta el estómago.



Disfagia orofaríngea (alta, de transferencia)

- Le cuesta **iniciar** la deglución: repite el intento.
- Señala la **garganta** (región cervical).
- Regurgitación inmediata por boca **o nariz**.
- Tos, sensación de ahogo, disfonía: el bolo entra en la vía aérea.
- Más difícil con **líquidos**.
- Riesgo: neumonía aspirativa.

Dónde señala el paciente y qué lo acompaña en cada tipo.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 00:49 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:00 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 10:06

Disfagia orofaríngea (alta o de transferencia) IMPRESCINDIBLE

> El problema está en el arranque de la deglución: por eso el bolo se escapa hacia la nariz o la vía aérea.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Estas características “no pueden olvidarse”: dificultad para iniciar la deglución, regurgitación inmediata por la boca o la nariz, tos y sensación de ahogo por aspiración, y disfonía.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:42 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 04:24

CÓMO SE PRESENTA

- **No puede iniciar la deglución**: repite una y otra vez el movimiento de tragar.
- Señala la **garganta** como sitio de la dificultad.
- **Regurgitación inmediata** del alimento por la boca o por la nariz: como no se transfiere, queda estancado arriba.
- **Tos, sensación de ahogo y disfonía**: pequeños fragmentos caen en la laringe.
- Le cuesta más con los **líquidos** (si los líquidos no pasan, tampoco pasan los sólidos).
- **Neumonía aspirativa**: el alimento llega al pulmón; es una causa de muerte en estos pacientes.

CAUSAS

GRUPO	EJEMPLOS	LO QUE TENÉS QUE RECORDAR
Neuromusculares (≈75 %)	ACV, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, miastenia gravis, miopatías inflamatorias	El **ACV es la causa número uno**; le sigue el Parkinson.
Trastornos motores locales	Disfunción del esfínter esofágico superior: **acalasia cricofaríngea**	El músculo cricofaríngeo no se relaja; más frecuente en mayores de 60 años.
Defectos estructurales	Inflamatorios (tuberculosis, abscesos), neoplasias, radiación, resecciones quirúrgicas, compresión extrínseca, divertículo de Zenker	Son menos frecuentes que los neuromusculares (≈25 % junto con los motores locales).

Porcentajes según la clase: las neuromusculares abarcan alrededor del 75 %.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

La causa neuromuscular más importante, “la número uno de todas”, es el ACV, que lesiona los pares craneales que permiten una buena deglución; le sigue la enfermedad de Parkinson.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 05:47 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 06:30

NOTA

En la transcripción automática el porcentaje inicial se escucha como “35 %”, pero más adelante el profesor aclara que la enfermedad neuromuscular abarca el **75 %** y las otras causas un 25 %. Se toma el valor coherente.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:42 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 10:06

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL

El divertículo de Zenker (por encima del cricofaríngeo) se clasifica habitualmente como causa estructural de disfagia **orofaríngea**: produce regurgitación de alimento no digerido y halitosis. En clase se lo menciona también como causa de compresión del esófago.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 15:28

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 03:00 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 07:22 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 09:26

Disfagia esofágica: mecánica u obstructiva vs motora o funcional

IMPRESCINDIBLE

> Una vez que sabés que es esofágica, la pregunta clave es: ¿solo con sólidos, o con sólidos y líquidos?

En la disfagia esofágica el paciente **pudo iniciar** la deglución; la molestia aparece **después** y la siente como atascamiento u opresión **retroesternal**, a veces en el hueco supraesternal o en la “boca del estómago”. No tiene regurgitación nasal ni tos, salvo que el esófago esté tan ocupado que el contenido llegue hasta arriba. Puede acompañarse de **dolor torácico**, **regurgitación tardía** y **odinofagia** por la presión dentro del esófago.

MECÁNICA VS MOTORA: EL CUADRO QUE TENÉS QUE PODER DIBUJAR

Mecánica u obstructiva

- Hay un **obstáculo** que reduce la luz.
- Disfagia para **sólidos** (pizza, carne, pan).
- **Continua y progresiva**: empeora con el tiempo.
- Solo se alivia cuando el paciente **regurgita** el alimento.

Motora, funcional o neuromuscular

- Falla el **peristaltismo** (control parasimpático) del cuerpo esofágico y del esfínter inferior.
- Disfagia para **sólidos y líquidos**.
- **Intermitente**, discontinua, impredecible; no progresiva o lentamente progresiva.
- El paciente levanta los brazos o se inclina para ayudar a que el bolo pase.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Lo que diferencia la mecánica de la motora: la mecánica es solo para sólidos, continua y progresiva; la motora es para sólidos y líquidos, intermitente e impredecible.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 12:48 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 13:28 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 14:08

CAUSAS DE DISFAGIA ESOFÁGICA

MECÁNICA · INTRÍNSECA

En la pared o la luz

Estenosis péptica por ERGE (la causa más frecuente de disfagia mecánica), **cáncer de esófago**, **anillo de Schatzki** (en el esfínter inferior), **síndrome de Plummer-Vinson** (membrana en el esófago superior), esofagitis.

MECÁNICA · EXTRÍNSECA

Algo que comprime desde afuera

Tumores mediastinales (lo más frecuente), **dilatación de la aurícula izquierda** en la estenosis mitral, divertículos, **bocio** o agrandamiento tiroideo.

MOTORA

Falla el motor

Acalasia (del esfínter inferior), **espasmo esofágico difuso**, **esclerodermia**.

Acalasia: por qué se dilata el esófago

Se pierde la inervación inhibitoria del plexo mientérico: el cuerpo esofágico deja de tener peristalsis y el esfínter inferior **no se relaja** (y aumenta su tono). El alimento se acumula y el esófago se dilata y alarga (**dolicomegaesófago**).

En la Argentina hay que pensar en la **enfermedad de Chagas** como causa secundaria. El libro agrega que la disfagia suele empezar con líquidos y luego con sólidos, con regurgitación y dolor torácico.

Estenosis péptica: del reflujo a la estrechez

CAUSA
ERGE crónica

→

MECANISMO
Ácido que lesiona la pared → inflamación y fibrosis

→

MANIFESTACIÓN
Disfagia para sólidos progresiva + pirosis de años

Esclerodermia: un esófago rígido que además refluye

En clase se la describe como un endurecimiento que termina lesionando la inervación. En términos fisiopatológicos, la fibrosis del músculo liso de los dos tercios inferiores produce **hipoperistalsis** y un esfínter inferior **incompetente**: por eso se combina disfagia motora con **pirosis** intensa.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 12:08 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 14:48 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 15:28 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 16:08 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 369

Cómo se diagnostica una disfagia

IMPRESCINDIBLE

> El diagnóstico es ante todo clínico: primero orofaríngea o esofágica, después mecánica o motora, y recién entonces la etiología.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

El diagnóstico más importante es el clínico. El primer paso es discriminar una disfagia orofaríngea de una esofágica; después, ver si el trastorno es mecánico o motor.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 18:10 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 18:50

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Odinofagia

Es **dolor al deglutir**, no dificultad. La causa más frecuente es la **faringoamigdalitis**; también esofagitis (*Candida*) o fármacos (clindamicina, doxiciclina, alendronato). Diferenciar origen respiratorio o digestivo.

Globo histérico

Sensación de "algo en la garganta" o de no poder respirar **sin relación con la ingesta**. Frecuente en pacientes ansiosos; se asocia a trastornos obsesivo-compulsivos o de la personalidad.

INTERROGATORIO DIRIGIDO

PREGUNTA	QUÉ ORIENTA
¿Puede tragar? ¿Dónde siente la molestia?	No puede iniciar / garganta → orofaríngea. Traga y se traba detrás del pecho → esofágica.
¿Con qué alimentos?	Líquidos → neuromuscular (orofaríngea). Solo sólidos → obstructiva. Sólidos y líquidos → motora.
¿Cómo evoluciona?	Intermitente → motora o anillo. Progresiva → obstrucción estructural.
¿Comenzó en forma brusca?	Típico del ACV.
¿Síntomas asociados?	Tos y regurgitación nasal → orofaríngea. Dolor torácico y pirosis → esofágica.
¿Perdió peso?	Pensar en **cáncer**.
¿Toma antiácidos?	Reflujo crónico → estenosis péptica o esofagitis.

LA QUE SIEMPRE SUELEN PREGUNTAR

Disfagia **intermitente y lentamente progresiva para sólidos y líquidos**, con regurgitación → lesión funcional: **acalasia**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 21:30

EXAMEN FÍSICO QUE SUMA

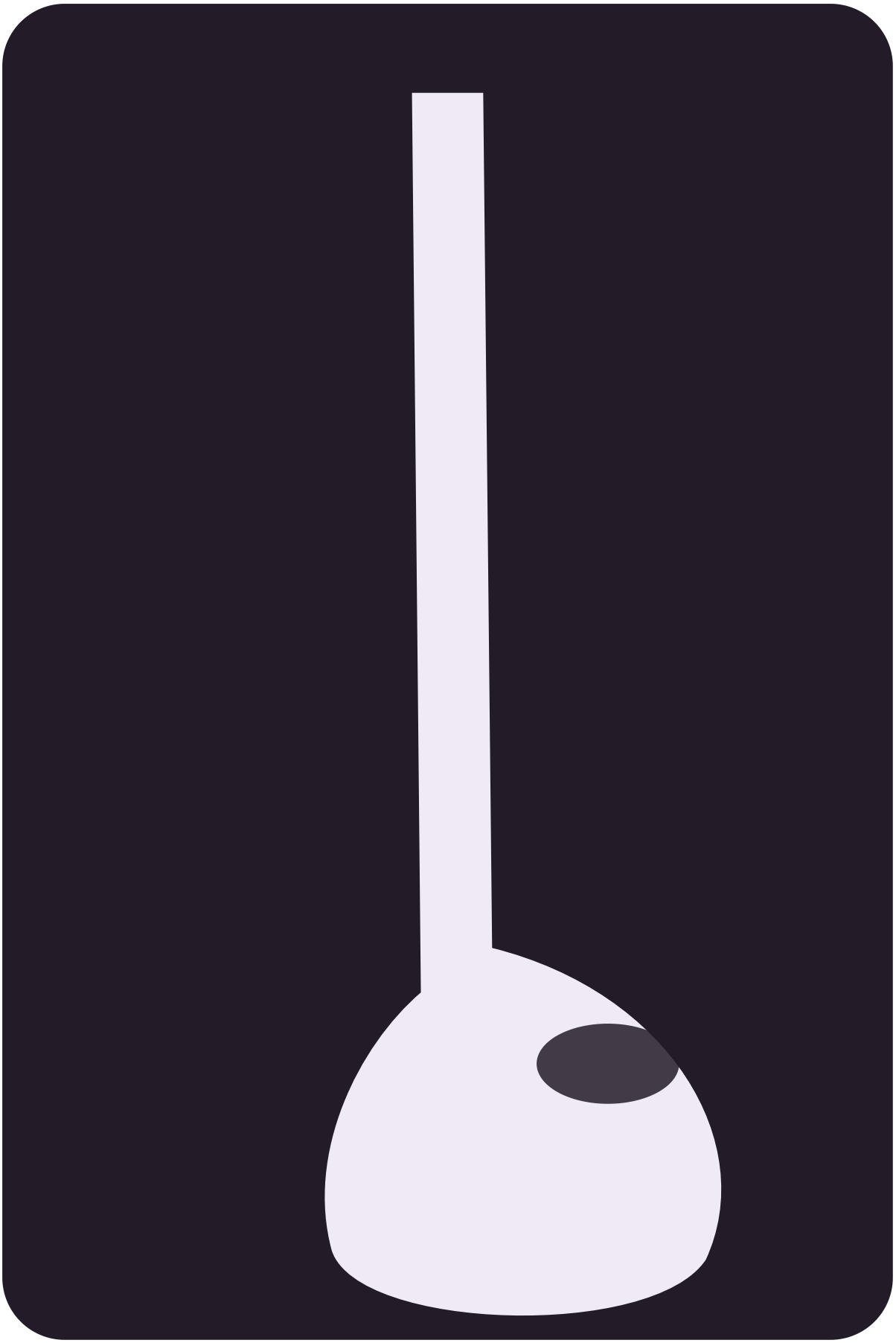
- Signos neurológicos (ACV), signos extrapiramidales (Parkinson), fatigabilidad muscular (miastenia gravis).
- Reflejos osteotendinosos lentos y agrandamiento tiroideo (hipotiroidismo, bocio).
- Adenopatías cervicales y **supraclaviculares**: el ganglio de **Virchow** sugiere una neoplasia digestiva.
- Esclerodactilia y telangiectasias (esclerodermia); **candidiasis oral** (inmunodepresión, esofagitis).

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SEGÚN EL PATRÓN

1. **Sospecha orofaríngea**
   Primero, **inspección de la orofaringe** con linterna y bajalenguas. Si no se ve nada, **endoscopía** del sector faríngeo. Si la causa es neurológica (ACV), estudio neurológico.

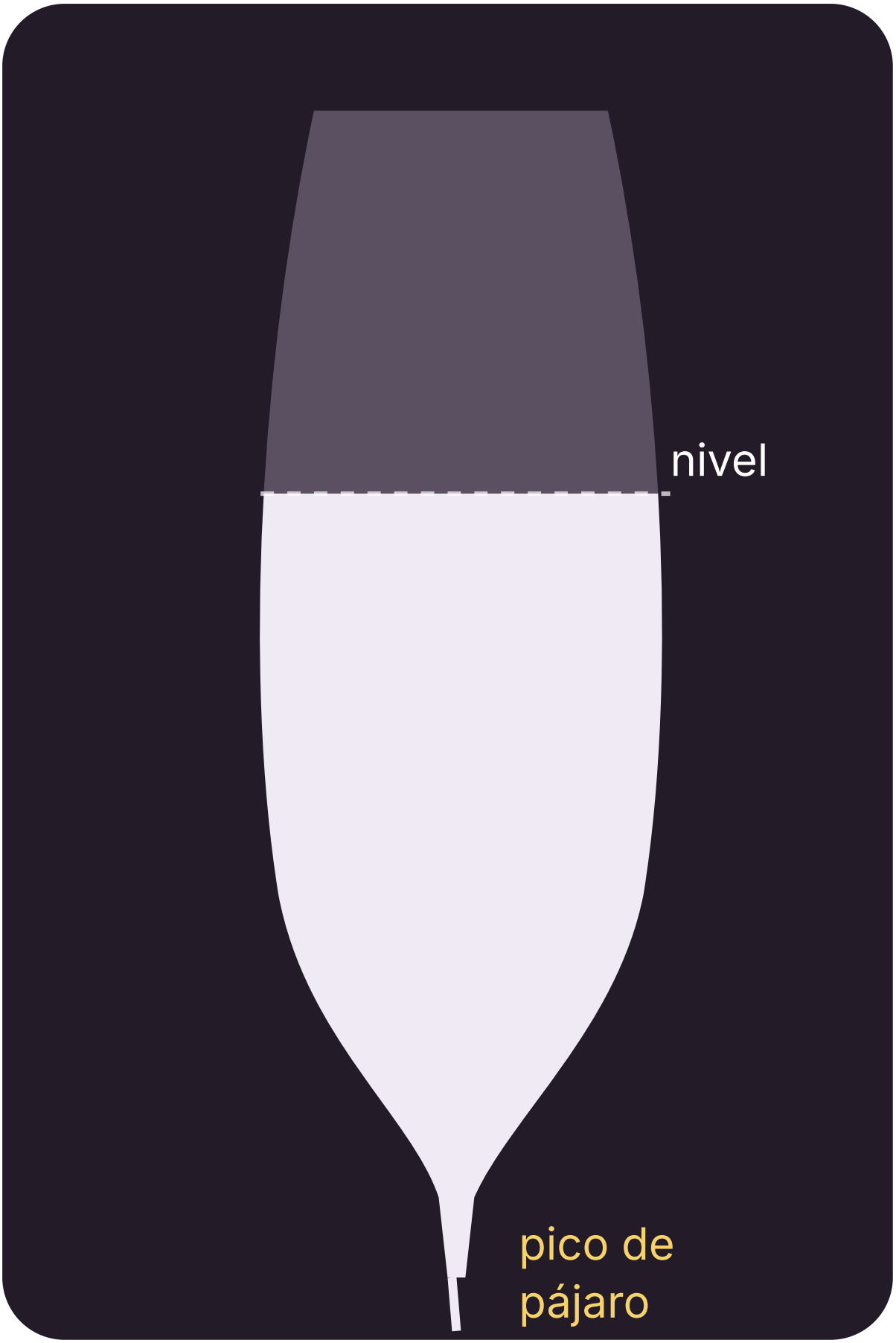
2. **Sospecha de trastorno motor (p. ej., acalasia, Chagas)**
   Manometría esofágica (mide el tono y la relajación de los esfínteres) y **esofagograma con bario**: dolicomegaesófago con imagen en **pico de pájaro** o **cola de ratón**.

3. **Sospecha de cáncer (> 50 años, pérdida de peso, tabaquismo)**
   Endoscopía digestiva alta con biopsia. En el esofagograma, la imagen en **manzana mordida**.



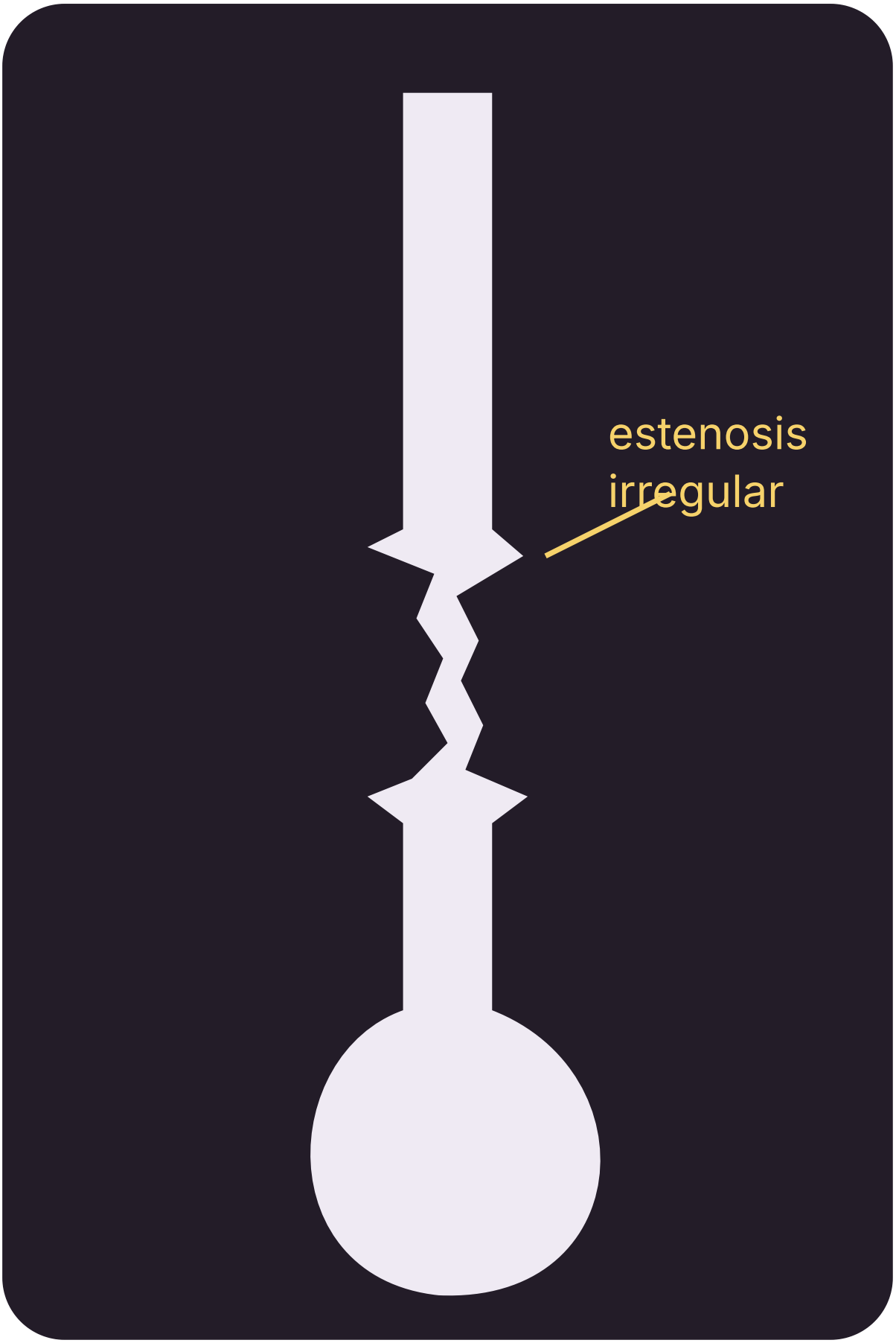
Normal

Calibre uniforme; burbuja de aire gástrico.



Acalasia

Dolicomegaesófago con nivel hidroaéreo y afinamiento liso “en pico de pájaro” (o cola de ratón).



Cáncer de esófago

Estrechez irregular y abrupta, con bordes en “manzana mordida”; se confirma con endoscopía y biopsia.

Esquemas originales de esofagograma con bario (el bario se ve blanco).

Paciente con disfagia

1.º ¿dónde se traba? · 2.º ¿con qué alimentos? · 3.º ¿cómo evoluciona?

CUESTA INICIAR

Disfagia orofaríngea

Tos, ahogo, regurgitación nasal; señala el cuello

Neuromuscular (≈75 %)

ACV (1.ª causa), Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, miastenia gravis, miopatías

Estructural / motora local

Acalasia cricofaríngea, divertículo de Zenker, tumores, radiación, cirugía

TRAGA Y SE ATASCA

Disfagia esofágica

Atascamiento retroesternal después de tragar

SOLO SÓLIDOS

Mecánica (obstructiva)

Continua y progresiva; alivia al regurgitar

INTERMITENTE

Anillo de Schatzki

o membrana esofágica

PROGRESIVA + PIROSIS

Estenosis péptica

por ERGE: causa más frecuente de disfagia mecánica

PROGRESIVA + > 50 AÑOS + PÉRDIDA DE PESO

Cáncer de esófago

SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Motora (funcional)

Intermitente, impredecible, no siempre progresiva

INTERMITENTE + DOLOR TORÁCICO

Espasmo esofágico difuso

PROGRESIVA + PIROSIS

Esclerodermia

LENTA Y PROGRESIVA + REGURGITACIÓN

Acalasia

Algoritmo de la clase, reorganizado. La estrella marca la pregunta típica de examen.

Caso de la clase

Varón de 42 años, no fuma ni bebe; refiere atascamiento retroesternal al comer. Hace tiempo le diagnosticaron enfermedad de Chagas.

¿Qué tipo de disfagia sospechás y qué estudios pedís?

Disfagia **esofágica motora** compatible con **acalasia chagásica** (el Chagas destruye el plexo mientérico y dilata el esófago). Se pide **manometría** y **esofagograma con bario** (dolicomegaesófago, pico de pájaro). Si tuviera más de 50 años, pérdida de peso o síntomas de alarma, se agrega **endoscopía con biopsia** para descartar cáncer.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 16:48 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 18:10 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 22:10 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 22:50 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 23:30 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 25:31

Dispepsia: definición y criterios de Roma

IMPRESCINDIBLE

> El famoso “dolor de la boca del estómago”: siempre por encima del ombligo y con síntomas definidos por consenso.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Es muy importante porque “se van a topar con la dispepsia o indigestión toda su vida”. Se ubica siempre en el abdomen superior, del ombligo hacia arriba.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 26:51 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 27:32

Dispepsia

Dolor o malestar localizado en el **epigastrio / abdomen superior**, agudo o crónico, continuo o intermitente, que puede acompañarse de distensión, eructos, pirosis, náuseas y vómitos. Se reconoce por la presencia de **plenitud posprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico o ardor epigástrico**.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 27:32 · Clase MC Digestivo · parte 1 · min 28:12

Síndrome de distrés posprandial

- Plenitud posprandial molesta
- Saciedad precoz

Se relaciona con la comida. Roma IV exige que ocurran al menos 3 días por semana.

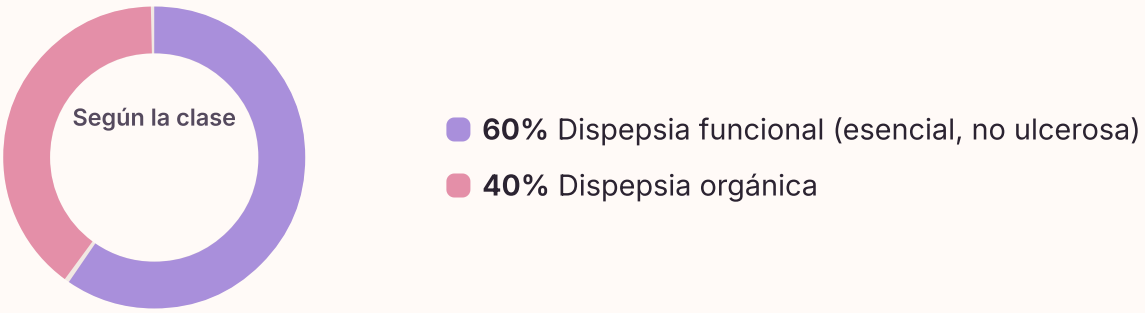
Síndrome de dolor epigástrico

- Dolor epigástrico
- Ardor epigástrico

Localizado, intermitente, no se alivia con la defecación ni los gases y no cumple criterios de dolor biliar. Roma IV: al menos 1 día por semana.

Para todos los casos

- Síntomas presentes en los últimos 3 meses...
- ...con comienzo al menos 6 meses antes del diagnóstico.
- Sin lesión estructural que los explique (endoscopía alta normal si se realizó).



Los dos síndromes de Roma y la proporción funcional/orgánica que da la clase.

Plenitud posprandial	Sensación de lleno y de que “le cayó mal” después de comer, como si hubiera comido en exceso.
Saciedad precoz	Come poco y ya no puede seguir, aunque tenga ganas de comer.
Dolor / ardor epigástrico	Dolor o quemazón localizados en el epigastrio, intermitentes, de intensidad moderada a severa.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Los criterios de Roma III se usan para definir la dispepsia funcional y “también lo van a aplicar para el síndrome de intestino irritable” y la constipación.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 34:10

PRECISIÓN SOBRE LOS CRITERIOS

En clase se explica la duración como “90 días de síntomas en 6 meses”. La redacción formal de Roma es: criterios presentes **durante los últimos 3 meses**, con **comienzo de los síntomas al menos 6 meses antes** del diagnóstico. Roma IV (2016) mantiene los dos síndromes y agrega frecuencia: distrés posprandial ≥ 3 días por semana; dolor epigástrico ≥ 1 día por semana. Aprendé la idea de la clase y, si te preguntan la definición textual, usá esta redacción.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 34:48

ERROR FRECUENTE

La dispepsia de la que hablamos acá es la **gástrica / epigástrica**. El profesor la diferencia de la “dispepsia” biliar y pancreática: si el dolor cumple criterios de cólico biliar o de patología pancreática, no es dispepsia funcional.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 30:52

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 26:51 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 28:52 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 29:32 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 34:10

Orgánica o funcional: causas y mecanismos

IMPRESCINDIBLE

> La funcional es la más frecuente, pero su diagnóstico es por exclusión: primero hay que descartar la orgánica.

Dispepsia orgánica (≈40 %)

- Hay una **enfermedad específica** que daña el estómago o el esófago.
- **Úlcera péptica**: la número uno, “la que no deben olvidarse”.
- Le siguen la **ERGE** y el **cáncer gástrico**.
- **Fármacos**: AINEs, antibióticos (p. ej., amoxicilina-clavulánico).
- Otras: diabetes, patología biliar o pancreática.

Dispepsia funcional (≈60 %)

- También **esencial** o **no ulcerosa**.
- Se diagnostica **por exclusión**: no reúne criterios de orgánica.
- Muy ligada al **estrés** y al nerviosismo (el clásico dolor antes de rendir un final).

ÉNFASIS DEL PROFESOR

La más frecuente, “la número uno que tienen que no olvidar nunca”, es la dispepsia funcional, esencial o no ulcerosa (60 %); la orgánica representa el 40 %, con la úlcera péptica a la cabeza.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 1 · min 30:52 Clase MC Digestivo · parte 1 · min 31:34

SUBTIPOS CLÍNICOS DE LA DISPEPSIA FUNCIONAL QUE SE DAN EN CLASE

Tipo reflujo

Acidez, regurgitación ácida y **pirosis** (ardor retroesternal).

Tipo ulcerosa

Dolor que **calma con antiácidos** (omeprazol, ranitidina) y a veces con la comida; puede despertar al paciente de noche.

Tipo dismotilidad

Retortijones por peristaltismo aumentado; **la comida empeora** el cuadro.

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL

Esta división (reflujo / ulcerosa / dismotilidad) es la clasificación clínica clásica. Desde Roma III se usan los síndromes de **distrés posprandial** y de **dolor epigástrico**, y los síntomas típicos de reflujo se consideran **ERGE**. Conviene conocer ambas.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 00:42

¿POR QUÉ DUELE UN ESTÓMAGO SIN LESIÓN? MECANISMOS

Disparadores

- **Factores psicológicos** — ansiedad, depresión, somatización, estrés
- **Factores externos** — comidas grasas, intolerancias alimentarias
- **Helicobacter pylori** — inflamación de la mucosa sin úlcera
- **Hipersecreción ácida** — y reflujo gastroesofágico

↓

Mecanismos (eje cerebro–estómago)

- **Falla de la acomodación fúndica** — el fundus no se relaja
- **Retraso del vaciamiento gástrico** — el contenido queda retenido
- **Hipersensibilidad visceral** — estímulos normales se sienten como dolor
- **Dismotilidad gastroduodenal**

↓

Lo que siente el paciente

- **Plenitud y saciedad precoz** — fundus que no acomoda, vaciamiento lento
- **Dolor o ardor epigástrico** — hipersensibilidad, ácido
- **Distensión, eructos, náuseas**

Disparadores → mecanismos del eje cerebro–estómago → síntomas.

- **Hipersensibilidad visceral**: el estómago responde con mucha secreción ácida o percibe como dolor estímulos normales (un mate, un té, una comida común).
- **Disminución de la actividad motora gastroduodenal**: el vaciamiento se retrasa, el contenido queda retenido y se secreta más ácido.
- **Reflujo gastroesofágico** por hipersecreción ácida.

- ***Helicobacter pylori***: es la causa número uno de gastritis bacteriana y de úlcera péptica; en la dispepsia funcional produce inflamación sin úlcera.
- **Factores psicológicos** (ansiedad, depresión, somatización, estrés): actúan en el sistema nervioso central y alteran la acomodación fúndica, la secreción y el vaciamiento.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

La causa más frecuente de dispepsia funcional son los trastornos psicogénicos y los factores externos: estrés, comidas grasas e intolerancias, que actúan a través del sistema nervioso central.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 05:32 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 06:13

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 00:01 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 02:45 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 04:09

Clínica, signos de alarma y conducta diagnóstica

IMPRESCINDIBLE

> La regla del profesor para la clínica: “las dos D y la P”. Y la pregunta que define la conducta: ¿hay alarma?

D

Dolor epigástrico

Después de comer o sin haber comido.

D

Distensión abdominal alta

Paciente hinchado, flatulento, con eructos y gases.

P

Pirosis

Ardor retroesternal por regurgitación; pueden sumarse náuseas y vómitos.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

“Siempre digo las dos D y la P”: dolor epigástrico, distensión abdominal alta y pirosis.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 07:34

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA (SUGIEREN DISPEPSIA ORGÁNICA)

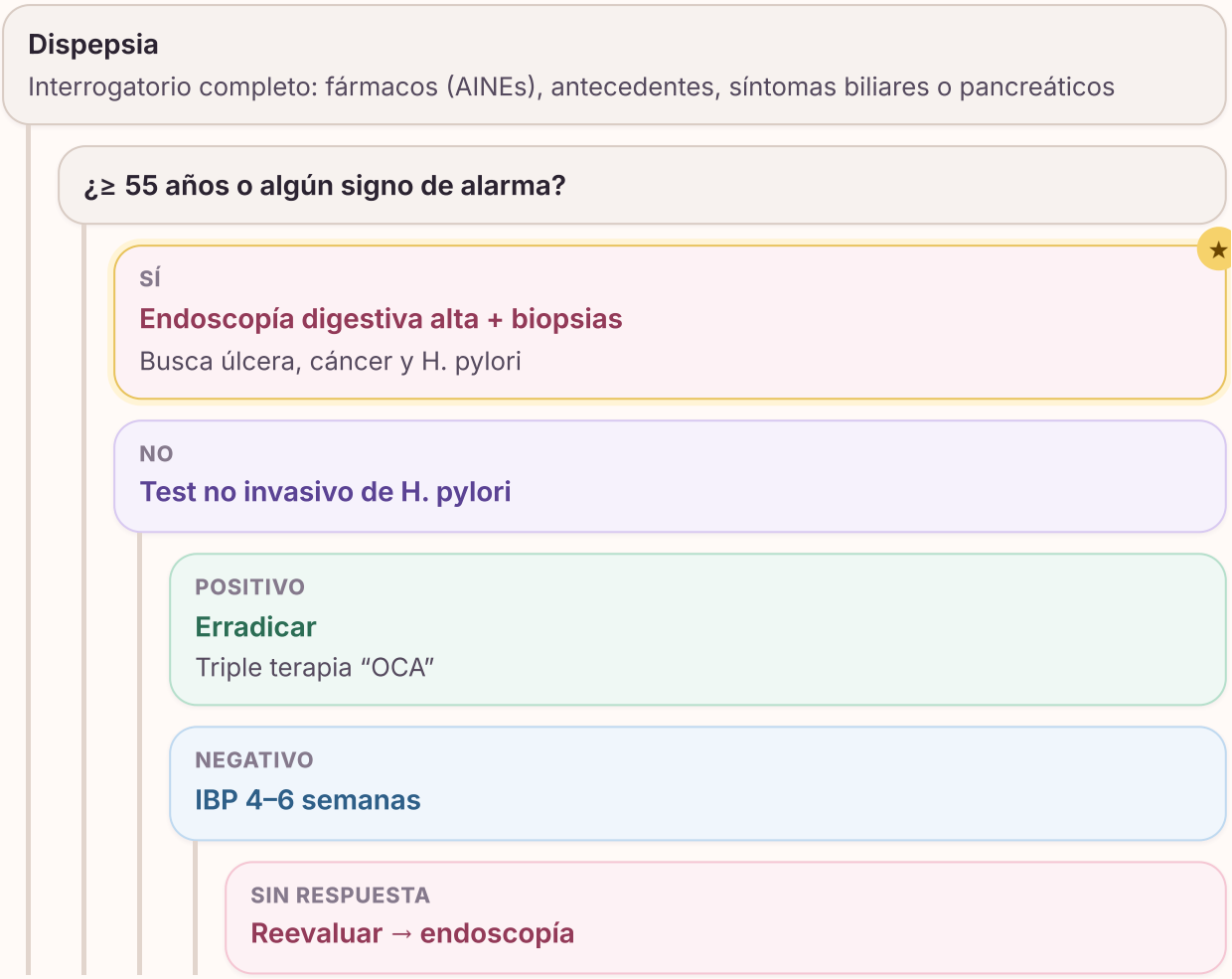
SIGNO DE ALARMA	QUÉ SOSPECHAR
Edad > 50–55 años	Mayor probabilidad de cáncer: endoscopía de entrada.
Pérdida de peso	Cáncer.
Hematemesis	Úlcera (u otra causa de hemorragia digestiva alta).
Vómitos persistentes	Síndrome pilórico.
Disfagia u odinofagia progresiva	Cáncer de esófago o de estómago que compromete el esófago inferior.
Ictericia	Proceso biliar, pancreático o hepático.
Anemia	Cáncer gástrico (sangrado y déficit de B12 por falta de factor intrínseco).
Uso de **AINEs**	Úlcera.
Antecedentes familiares de cáncer, cirugía gástrica previa, fracasos terapéuticos	Organicidad.

POR QUÉ LA ANEMIA

El cuerpo gástrico produce **factor intrínseco**, que transporta la vitamina B12 hasta el íleon terminal. Un cáncer de estómago puede asociarse a déficit de B12 (anemia megaloblástica); en la práctica también es muy frecuente la **ferropenia** por sangrado oculto.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 09:34

CONDUCTA



Algoritmo de la clase. La endoscopía digestiva alta es la prueba que confirma úlcera o cáncer.

- Las dispepsias funcionales se diagnostican **por exclusión**.
- Edad ≥ 55 años o signos de alarma → **endoscopía digestiva alta (VEDA) con biopsia**, que además permite buscar *H. pylori*.
- Menor de 55 años sin alarma → **prueba para* H. pylori***: si es positiva se trata; si es negativa,** inhibidor de la bomba de protones 4–6 semanas** y reevaluar; si fracasa, endoscopía.
- Tratamiento de *H. pylori* que se menciona en clase: la regla **"OCA"** — **O**meprazol, **C**laritromicina, **A**moxicilina.

PRECISIONES

- En clase se nombra “la prueba de la ureasa”. Para estrategias sin endoscopía se usan pruebas **no invasivas** (test del aire espirado con urea marcada —que detecta la ureasa de la bacteria— o antígeno en materia fecal); la prueba rápida de ureasa propiamente dicha se hace sobre una biopsia.
- En la grabación la “A” de OCA se escucha como amoxicilina-clavulánico; la triple terapia clásica usa **amoxicilina**. Las guías actuales prefieren esquemas de 14 días y, donde la resistencia a la claritromicina es alta, terapias cuádruples.
- El umbral de edad varía: en clase se mencionan 45–50 y 55 años; algunas guías actuales usan 60.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 10:54 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 11:34 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 12:14

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 07:34 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 08:14 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 10:14

Náuseas, vómito y sus parientes: definiciones

IMPRESCINDIBLE

> Antes de clasificar un vómito hay que asegurarse de que sea un vómito y no una regurgitación o una rumiación.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Lo habitual es que el paciente consulte por náuseas y vómitos juntos. Que alguien vomite **sin náuseas previas** es llamativo y obliga a pensar en causas particulares.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 13:51

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Vómito (emesis)	Expulsión **activa**, por la boca, del contenido gástrico o duodenal.
Náusea	Sensación de **deseo de vomitar**; suele preceder al vómito.
Arcadas	Contracciones rítmicas del abdomen (y de músculos respiratorios) que preceden al vómito, sin expulsión.
Regurgitación	Retorno **sin esfuerzo** del contenido esofágico o gástrico a la boca, sin náusea ni contracción abdominal.
Rumiación	El contenido gástrico vuelve a la boca y el paciente **lo vuelve a tragar**.
Hematemesis	Vómito de sangre: rojo rutilante o en borra de café. Indica origen en el tubo digestivo **alto** (esófago, estómago, duodeno).

LA PREGUNTA QUE SEPARA VÓMITO DE REGURGITACIÓN

"¿Lo expulsó usted o le subió solo a la boca?". Si sube sin esfuerzo y lo vuelve a tragar, es rumiación; si sube sin esfuerzo con pirosis, regurgitación; si hubo náusea, arcadas y expulsión, es vómito.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 26:37

PARA ENTENDERLO

Recordá el reflejo de las bases: la náusea y las arcadas son las primeras etapas del mismo reflejo; la hipertensión endocraneana puede saltearlas y producir un vómito en chorro.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 14:31 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 15:11 Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. 368

Semiología del vómito: qué contiene, cuándo aparece y qué lo acompaña

IMPRESCINDIBLE

> El vómito "viaja en el tiempo": cuanto más procesado llega, más lejos se originó. Y el horario dice tanto como el color.

SEGÚN EL TIPO DE VÓMITO



Vómito alimenticio

Aspecto: Alimentos casi enteros, sin digerir y con poco ácido.

De dónde viene: Esófago (nunca llegó al estómago).

Pensar en: Acalasia, estenosis, divertículo; suele acompañarse de opresión retroesternal.

Elegí un tipo de vómito para ver de qué tramo proviene y qué sugiere.

- **Alimenticio**: la comida vuelve tal como se comió, casi sin ácido → **esófago** (suele acompañarse de opresión retroesternal).
- **Parcialmente digerido / ácido**: mucho líquido ácido con restos → **estómago**: gastroparesia, obstrucción pilórica, distensión gástrica.
- **Bilioso**: amarillo-verdoso, deja **sabor amargo** → el profesor lo vincula a causas **pancreáticas, hepáticas y biliares**.
- **Hemático**: **rojo** claro = sangrado **activo**; **borra de café** = sangre “vieja”, ya digerida. Primero descartar **úlcera**; después várices esofágicas (sangre venosa abundante), Mallory-Weiss, cáncer.
- **Fecaloide**: marrón, de olor fecal → obstrucción del intestino **bajo** (p. ej., yeyuno estrangulado) o **fístula gastrocólica**.

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL

Para que el vómito sea bilioso, el contenido duodenal tiene que poder refluir al estómago: implica un píloro permeable (vómitos repetidos) o una obstrucción por debajo de la papila de Vater. Por eso el **síndrome pilórico** da vómitos **sin bilis**.

SEGÚN EL MOMENTO

AL DESPERTAR, EN AYUNAS

Embarazo · Alcohol · HTE

Las tres causas más frecuentes que remarca el profesor: embarazo, haber tomado alcohol la noche anterior, hipertensión endocraneana.

≈ 1 HORA DESPUÉS DE COMER

Estómago

Gastritis, úlcera, distensión gástrica.

VARIAS HORAS DESPUÉS

Píloro

Vómito de retención con alimentos de comidas previas: síndrome pilórico.

POR LA NOCHE

Organicidad

El vómito nocturno casi siempre obedece a una causa orgánica.

Lo que sugiere cada horario.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Si el vómito es por la mañana, antes de comer, hay que pensar siempre en tres cosas: embarazo, alcohol la noche anterior o presión endocraneana aumentada. El vómito una hora después de comer orienta al estómago; varias horas después, al píloro.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 19:13 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 19:53

SEGÚN LO QUE LO ACOMPAÑA

ACOMPAÑANTE	ORIENTACIÓN
Dolor en hipocondrio derecho + vómito bilioso	Patología biliar o hepática.
Ictericia, cambios en orina y heces	Proceso hepatobiliar (repasar ictericia).
Pérdida de peso	Cáncer o síndrome pilórico (no vacía, vomita, se deshidrata).
Vértigo y acúfenos	Enfermedad de Ménière.
Vómito **en chorro, sin náuseas**, con cefalea	**Hipertensión endocraneana**.
Fiebre	Proceso infeccioso.
Diarrea	Gastroenteritis (tubo digestivo bajo).
El dolor epigástrico **cede al vomitar**	Úlcera.
Más de **1.500 ml en 24 horas**	Causa orgánica.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 15:51 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 17:13 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 18:33 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 20:34 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 21:54 · Clase MC Digestivo · parte 2 · min 22:35

Complicaciones del vómito

IMPRESCINDIBLE

> Se preguntan en el examen. Cada una se deduce de lo que se pierde (ácido, agua, potasio) o del esfuerzo mecánico.

ÉNFASIS DEL PROFESOR

Las complicaciones del vómito se preguntan en la cátedra: al vomitar se pierde ácido y potasio —hipopotasemia y alcalosis metabólica— además de líquido, con deshidratación.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 23:15

Se pierde por la boca

- **Ácido clorhídrico** (H^+ y Cl^-)
- **Agua y sodio**
- Algo de potasio

↓

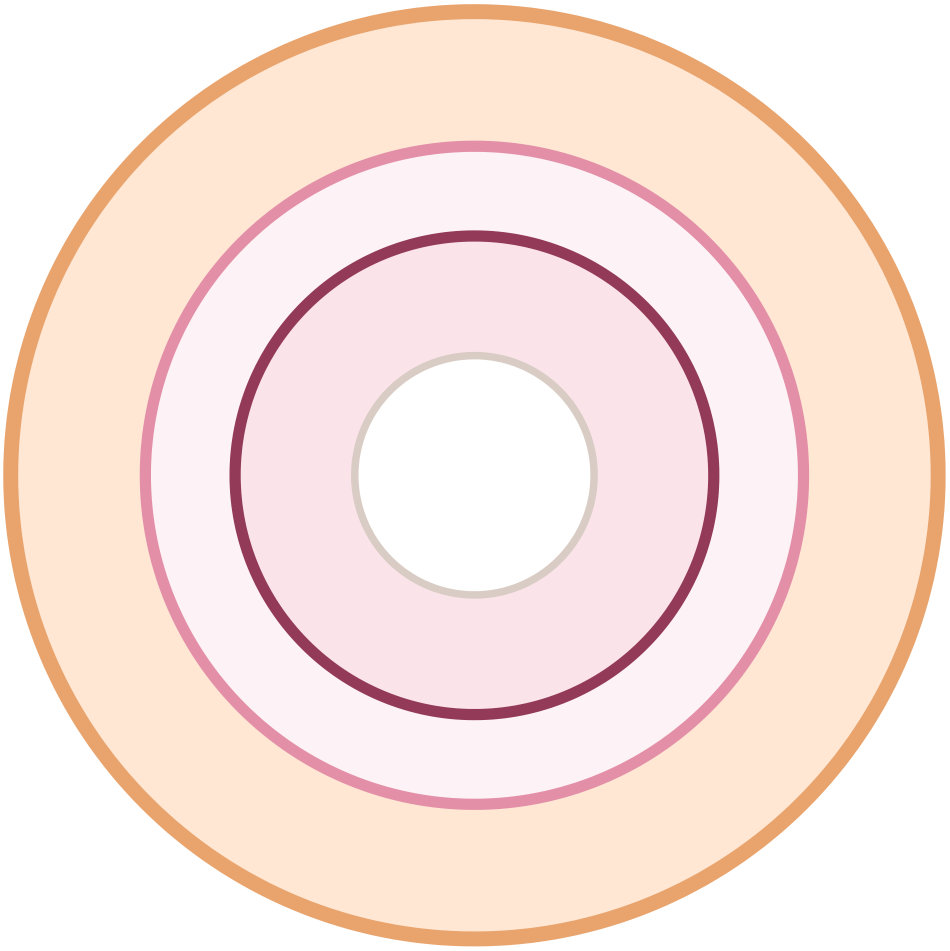
El organismo responde

- Sin H^+ que neutralizar, sube el bicarbonato.
- La hipovolemia activa la aldosterona: el riñón retiene sodio y elimina potasio.

↓

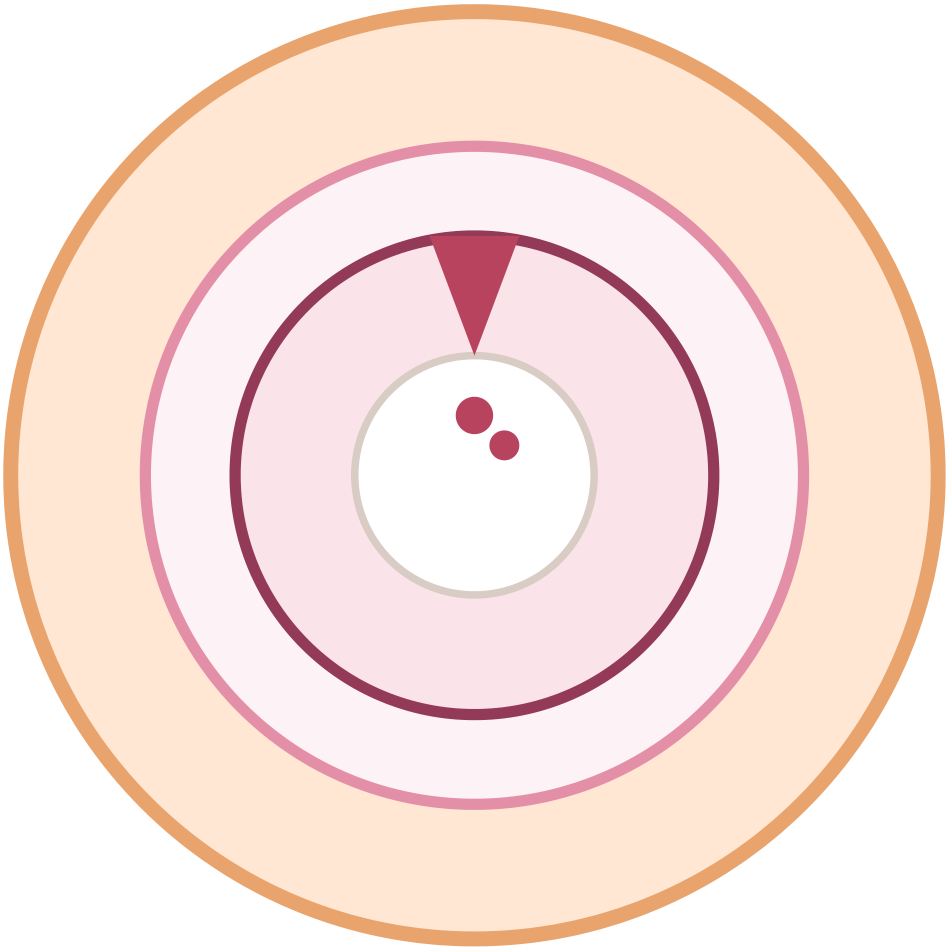
Resultado

- **Alcalosis metabólica**
- **Hipopotasemia** (la mayor pérdida es renal)
- **Deshidratación**: taquicardia, hipotensión



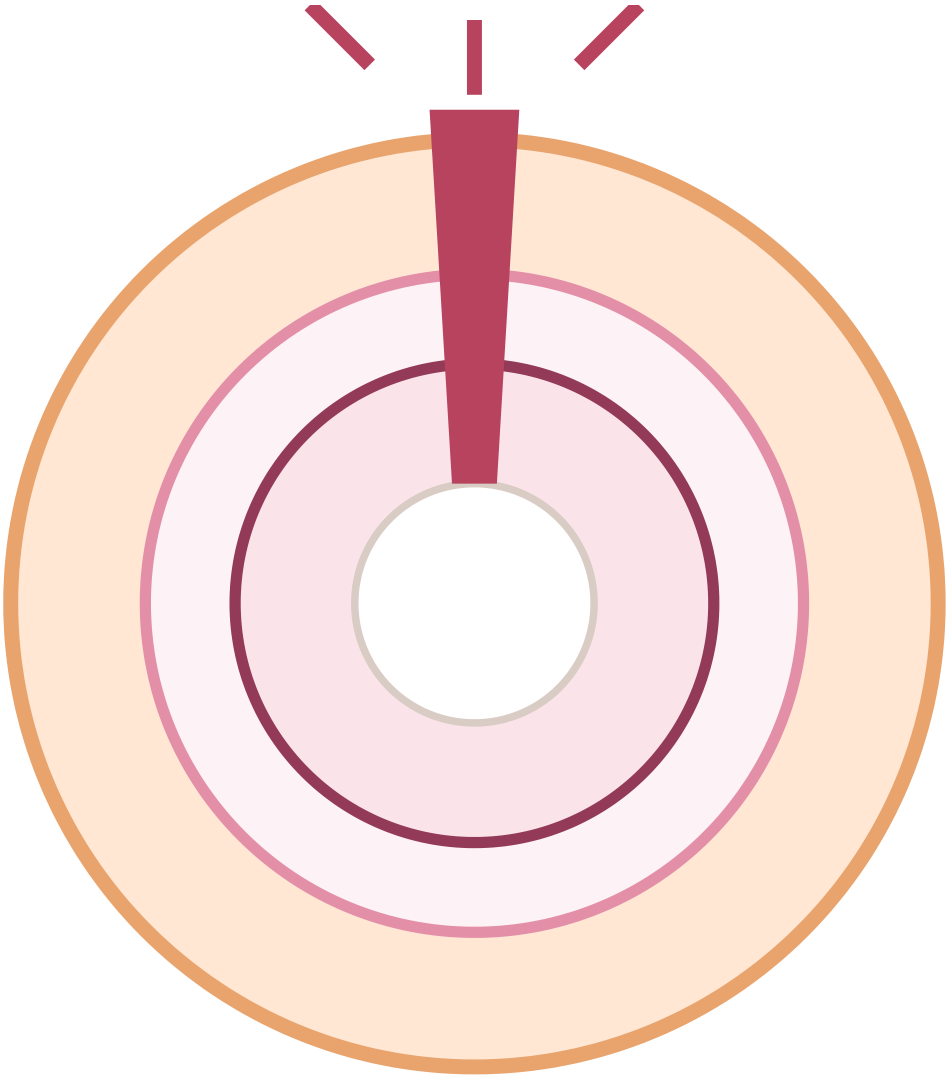
mucosa · submucosa · muscular

Pared esofágica normal



mucosa · submucosa · muscular

Mallory-Weiss: desgarro de la *mucosa* de la unión gastroesofágica por arcadas o vómitos intensos (típico del alcohólico) → hematemesis.



mucosa · submucosa · muscular

Boerhaave: rotura de *todo el espesor* del esófago → el contenido pasa al mediastino (mediastinitis). Emergencia.

Arriba, las complicaciones metabólicas; abajo, las mecánicas.

LAS CINCO COMPLICACIONES

1. **Alcalosis metabólica**
   Se pierde ácido clorhídrico: el bicarbonato queda sin contrapartida y sube el pH.

2. **Hipopotasemia**
   Se pierde algo de potasio con el vómito, pero la mayor pérdida es **renal**: la alcalosis y la hipovolemia (que activa la aldosterona) hacen que el riñón elimine potasio.

3. **Deshidratación**
   Taquicardia compensadora e hipotensión por la caída de la volemia.

4. **Neumonitis química y neumonía aspirativa**
   Al aspirar el vómito, el ácido inflama el pulmón (neumonitis química) y luego se coloniza (neumonía aspirativa): puede ser la causa de muerte.

5. **Lesiones esofágicas**
   Mallory-Weiss: desgarro de la mucosa de la unión gastroesofágica, típico del alcohólico, que sangra. **Boerhaave**: rotura de todo el espesor del esófago con paso del contenido al mediastino.

SOBRE LA TRÍADA DE MALLORY-WEISS

El profesor la presenta como una tríada: alcoholismo, desgarro de la mucosa gastroesofágica y un tercer elemento que no se escucha con claridad en la grabación. En la bibliografía, la presentación típica es la **hematemesis después de vómitos o arcadas intensas** en un paciente alcohólico.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 24:37

BIBLIOGRAFÍA ACTUAL

La neumonitis química por aspiración de contenido gástrico se conoce también como síndrome de Mendelson.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 23:15 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 23:55 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 24:37

Abordaje del paciente que vomita

MUY IMPORTANTE

> El vómito es casi siempre un síntoma acompañante: el contexto, el examen y un laboratorio básico ordenan el diagnóstico.

CONTEXTO CLÍNICO: DÓNDE PUEDE ORIGINARSE

Urgencias abdominales

Abdomen agudo inflamatorio ("todo lo que termina en *-itis*": apendicitis, colecistitis, pancreatitis) y obstrucciones.

Tubo digestivo e infecciones

Cualquier lesión del tubo digestivo, gastroenteritis, infecciones sistémicas (p. ej., neumonía).

Sistema nervioso

Hipertensión endocraneana (incluida la meningitis), enfermedad de Ménière.

Metabólicas y fármacos

Alteraciones metabólicas y medicamentos.

Cardíacas

El infarto puede presentarse con vómitos.

Fisiológicas

Embarazo (hiperémesis gravídica).

INTERROGATORIO

- ¿Es vómito, regurgitación o rumiación?
- ¿Desde cuándo? En clase: agudo < 7 días, crónico > 7 días (las guías consideran crónico a partir de las 4 semanas).
- ¿Cuánto? (más de 1,5 litros sugiere organicidad) ¿Cuántas veces? ¿Tuvo náuseas antes?
- ¿Cuándo aparece? (mañana, noche, antes o después de comer) ¿Color? ¿Sabor?
- ¿Toma medicación? ¿Qué otros síntomas tiene?

EXAMEN FÍSICO

- **Signos vitales**: taquicardia compensadora, hipotensión por hipovolemia, temperatura (fiebre si hay infección).
- **Signos de deshidratación**: mucosas secas, turgencia y elasticidad de la piel, palidez.
- **Abdomen**: distensión, peristaltismo visible, ictericia; dolor espontáneo o a la palpación; **chapoteo gástrico** (síndrome pilórico).
- **Neurológico**: fondo de ojo (hipertensión endocraneana), signos de Ménière, **asterixis**, signos de neuropatía autonómica.

LA REGLA DEL LABORATORIO: CEUCGO

Citológico completo (hemograma), **E**ritrosedimentación, **U**rea, **C**reatinina, **G**lucemia y **O**rina completa. "Pero no hay que olvidar nunca el **ionograma**": estos pacientes tienden a la hipopotasemia y a la alcalosis metabólica.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 30:40 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 30:48

- Según la sospecha: **hepatograma**, **amilasa**, albúmina, calcemia.

- En mujeres en edad fértil: **test de embarazo** (hiperémesis gravídica).
- Imágenes (radiografía de abdomen, ecografía) y **endoscopía alta** según la etiología sospechada: por ejemplo, ante un vómito por úlcera péptica, endoscopía.

FUENTE Clase MC Digestivo · parte 2 · min 25:17 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 26:37 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 28:39 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 29:19 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 30:00 Clase MC Digestivo · parte 2 · min 30:40

Fichas de consulta rápida

Disfagia en una tabla

	OROFARÍNGEA	ESOFÁGICA MECÁNICA	ESOFÁGICA MOTORA
Inicio de la deglución	Dificultad para iniciar	Normal; se traba después	Normal; se traba después
Alimentos	Más difícil con líquidos	Sólidos	Sólidos y líquidos
Evolución	Según la causa (brusca en el ACV)	Continua y progresiva	Intermitente, impredecible
Dónde la siente	Garganta	Retroesternal / epigastrio	Retroesternal
Acompañantes	Regurgitación nasal, tos, ahogo, disfonía	Pérdida de peso, pirosis crónica	Dolor torácico, regurgitación
Causas clave	ACV, Parkinson, miastenia, acalasia cricofaríngea	Estenosis péptica, cáncer, Schatzki	Acalasia, espasmo difuso, esclerodermia
Primer estudio	Inspección orofaríngea, endoscopía	Endoscopía con biopsia	Manometría, esofagograma

Vómito: qué me dice

CARACTERÍSTICA	SUGIERE
Alimentos sin digerir	Esófago
Ácido, parcialmente digerido	Estómago (gastroparesia, obstrucción pilórica)

CARACTERÍSTICA	SUGIERE
Bilioso (amarillo-verde, amargo)	Patología biliar, pancreática o hepática; nunca síndrome pilórico puro
Rojo rutilante / borra de café	Hemorragia digestiva alta activa / ya digerida
Fecaloide	Obstrucción intestinal baja, fístula gastrocólica
Matinal en ayunas	Embarazo, alcohol, hipertensión endocraneana
Varias horas después de comer	Síndrome pilórico
En chorro sin náuseas	Hipertensión endocraneana

Dispepsia: conducta

SITUACIÓN	CONDUCTA
≥ 55 años o algún signo de alarma	Endoscopía digestiva alta con biopsias
< 55 años, sin alarma	Test de *H. pylori* (no invasivo)
H. pylori positivo	Erradicar (OCA: omeprazol + claritromicina + amoxicilina)
H. pylori negativo	IBP 4–6 semanas
Sin respuesta	Reevaluar y endoscopía

Memoria activa

¿Disfagia alta o baja?

Para qué sirve: Ubicar el tramo afectado con la primera pregunta del interrogatorio.

- Si puede **iniciar** la deglución.
- Dónde **señala** la molestia.
- Si hay **tos, ahogo o regurgitación nasal**.

Cómo interpretarlo: No puede arrancar, señala el cuello y tose → orofaríngea. Traga bien y se le traba detrás del esternón → esofágica.

Mnemotecnia: Arriba se ATRAGANTA, abajo se ATASCA. — La orofaríngea "se atraganta" (tos, ahogo, sale por la nariz); la esofágica "se atasca" detrás del pecho después de tragar.

Mecánica vs motora

Para qué sirve: Diferenciar los dos grandes mecanismos de la disfagia esofágica.

	MECÁNICA	MOTORA
Alimentos	Sólidos	Sólidos y líquidos
Curso	Continua, progresiva	Intermitente, impredecible
Ejemplos	Estenosis péptica, cáncer, Schatzki	Acalasia, espasmo, esclerodermia

Cómo interpretarlo: Si solo pasan mal los sólidos, hay un obstáculo; si pasan mal sólidos y líquidos, falla el peristaltismo.

Mnemotecnia: MURO o MOTOR. — Un **muro** (obstáculo) deja pasar el agua pero no la piedra: solo sólidos. Un **motor** roto no empuja nada: sólidos y líquidos.

Clínica de la dispepsia: 2 D + P

Para qué sirve: Recordar los síntomas centrales con la regla que usa el profesor.

- **D**olor epigástrico.
- **D**istensión abdominal alta (eructos, gases).
- **P**irosis (con regurgitación; pueden sumarse náuseas y vómitos).

Cómo interpretarlo: La presencia de estos síntomas define el cuadro clínico; no distingue entre orgánica y funcional: para eso están los signos de alarma.

Mnemotecnia: "Las dos D y la P". — Regla textual de la clase: dolor, distensión, pirosis.

Signos de alarma en dispepsia

Para qué sirve: Decidir quién necesita endoscopía.

LETRA	SIGNO
V	Vómitos persistentes
I	Ictericia
D	Disfagia u odinofagia progresiva
A	Anemia
P	Pérdida de peso
E	Edad > 55 años
S	Sangrado (hematemesis, melena)
A	AINEs y Antecedentes (cáncer familiar, cirugía gástrica)

Cómo interpretarlo: Cualquiera de estos datos sugiere organicidad: endoscopía digestiva alta con biopsia.

Mnemotecnia: Una VIDA que PESA → VEDA. — VIDA (Vómitos, Ictericia, Disfagia, Anemia) + PESA (Pérdida de peso, Edad, Sangrado, AINEs/Antecedentes) → VEDA (videoendoscopía digestiva alta). Mnemotecnia original.

El vómito viaja en el tiempo

Para qué sirve: Relacionar el contenido del vómito con el nivel de origen.

CONTENIDO	ORIGEN
Alimentos enteros	Esófago
Ácido, parcialmente digerido	Estómago
Bilis (amargo, verde-amarillo)	Duodeno / patología biliopancreática
Fecaloide	Intestino distal
Rojo / borra de café	Sangrado alto activo / pasado

Cómo interpretarlo: Cuanto más "procesado" llega el contenido, más lejos se originó. La sangre roja es presente; la borra de café, pasado.

Mnemotecnia: Entero → Ácido → Amargo → Fecal. — Seguí el recorrido del alimento: primero sale como entró (esófago), después ácido (estómago), luego amargo con bilis (duodeno) y al final fecal (intestino distal).

El reloj del vómito

Para qué sirve: Usar el horario del vómito para orientar la causa.

- Matinal en ayunas → **E**mbarazo, **A**lcohol, **H**ipertensión endocraneana.
- ≈ 1 hora después de comer → estómago.
- Varias horas después → píloro.
- Nocturno → organicidad.

Cómo interpretarlo: El horario no da el diagnóstico solo, pero recorta mucho las posibilidades.

Mnemotecnia: "¡EAH, qué mañana!" — Vómito matinal = Embarazo, Alcohol, HTE. Luego, cuanto más tarde después de comer, más distal el problema (estómago → píloro).

Complicaciones del vómito

Para qué sirve: Anticipar y explicar lo que puede salir mal en un paciente que vomita mucho.

- Alcalosis metabólica (pierde HCl).
- Hipopotasemia (sobre todo renal).
- Deshidratación.
- Neumonitis química → neumonía aspirativa.
- Mallory-Weiss (mucosa) y Boerhaave (todo el espesor).

Cómo interpretarlo: Las tres primeras se corrigen con hidratación y potasio; las mecánicas y la aspiración son potencialmente graves.

Mnemotecnia: Mallory = Mucosa · Boerhaave = Boom. — Mallory-Weiss rasga la **M**ucosa (sangra); Boerhaave hace **¡Boom!**: estalla todo el espesor y se contamina el mediastino.

Laboratorio inicial: CEUCGO + iono

Para qué sirve: Pedir un laboratorio básico completo ante un paciente con vómitos.

- **C**itológico completo (hemograma).
- **E**ritrosedimentación.
- **U**rea.
- **C**reatinina.
- **G**lucemia.
- **O**rina completa.
- + **Ionograma** (potasio, cloro).

Cómo interpretarlo: Detecta deshidratación (urea, creatinina), alteraciones metabólicas (glucemia), infección (hemograma, eritrosedimentación) y trastornos del potasio.

Mnemotecnia: CEUCGO… y el iono no se olvida. — Sigla que da el profesor; él mismo agrega “no hay que olvidar nunca el ionograma”.

Integración: lo imprescindible

- Disfagia orofaríngea = alta = de transferencia: no puede iniciar, tos, ahogo, regurgitación nasal; **ACV** primera causa.
- Disfagia esofágica = baja = de transporte. Solo sólidos y progresiva → **mecánica** (estenosis péptica, cáncer); sólidos y líquidos e intermitente → **motora** (acalasia, espasmo, esclerodermia).
- Pregunta típica: disfagia lentamente progresiva para sólidos y líquidos con regurgitación → **acalasia** (pico de pájaro, manometría; pensar en Chagas).

- Dispepsia (Roma): plenitud posprandial, saciedad precoz, dolor o ardor epigástrico; **funcional 60 %**, orgánica 40 % (úlcera péptica primero).
- Signos de alarma → **endoscopía**; joven sin alarma → test de *H. pylori*.
- Vómito: el contenido indica el nivel; el horario orienta la causa (matinal: embarazo, alcohol, HTE; varias horas después: píloro).
- Complicaciones: **alcalosis metabólica hipopotasémica**, deshidratación, aspiración, Mallory-Weiss y Boerhaave.

Desarrollos modelo

1. Defina disfagia y desarrolle las diferencias semiológicas entre la disfagia orofaríngea y la esofágica, con sus causas principales.

Definición. La disfagia es la dificultad para el pasaje del alimento desde la boca hasta el estómago. Puede responder a una causa orgánica, por lo que nunca debe desestimarse. Se divide según el tramo afectado.

Bases. La deglución tiene tres mecanismos: uno voluntario (oral: masticación y propulsión del bolo) y dos involuntarios (faríngeo y esofágico), dependientes del sistema autónomo, sobre todo parasimpático.

	OROFARÍNGEA (ALTA, DE TRANSFERENCIA)	ESOFÁGICA (BAJA, DE TRANSPORTE)
Qué falla	Pasaje de la boca a la faringe y el esófago superior	Transporte por el cuerpo esofágico y el esfínter inferior
Inicio	No puede iniciar la deglución	Traga bien; el problema aparece después
Localización	Garganta	Retroesternal, hueco supraesternal o epigastrio
Acompañantes	Regurgitación inmediata oral o nasal, tos, ahogo, disfonía, neumonía aspirativa	Opresión y dolor torácico, regurgitación tardía, odinofagia
Alimentos	Más difícil con líquidos	Sólidos (mecánica) o sólidos y líquidos (motora)

Causas de la orofaríngea. Neuromusculares (≈75 %): ACV —la primera causa—, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, miastenia gravis, miopatías. Trastornos motores locales: acalasia cricofaríngea. Estructurales: tumores, inflamatorias, radiación, cirugía, divertículo de Zenker.

Causas de la esofágica. Mecánicas intrínsecas (estenosis péptica —la más frecuente—, cáncer, anillo de Schatzki, Plummer-Vinson) y extrínsecas (tumores mediastinales, aurícula izquierda dilatada, bocio); motoras (acalasia, espasmo esofágico difuso, esclerodermia).

Conducta. El diagnóstico es clínico: primero se define orofaríngea vs esofágica y luego mecánica vs motora; los estudios (inspección orofaríngea, endoscopía, manometría, esofagograma) se eligen según ese patrón.

2. Compare la disfagia esofágica mecánica y la motora: fisiopatología, características clínicas y causas.

Mecánica u obstructiva. Hay un obstáculo que reduce la luz esofágica. Como un sólido no pasa por una luz estrecha pero un líquido sí, la disfagia es para **sólidos**; es **continua y progresiva** porque el obstáculo crece, y solo se alivia cuando el paciente regurgita. Causas intrínsecas: estenosis péptica por ERGE (la más frecuente), cáncer de esófago, anillo de Schatzki, Plummer-Vinson. Extrínsecas: tumores mediastinales, dilatación de la aurícula izquierda en la estenosis mitral, bocio, divertículos.

Motora, funcional o neuromuscular. Falla el **peristaltismo** del cuerpo esofágico y/o la relajación del esfínter inferior (control parasimpático). Sin "motor", no progresa ni el sólido ni el líquido: la disfagia es para **sólidos y líquidos**, **intermitente** e impredecible, no progresiva o lentamente progresiva; el paciente adopta maniobras (levantar los brazos, inclinarse) para ayudar al pasaje. Causas: acalasia, espasmo esofágico difuso, esclerodermia.

Cómo lo uso en el examen. La pregunta "¿con qué alimentos?" separa ambos grupos; la evolución y los acompañantes afinan: intermitente para sólidos → anillo; progresiva con pirosis → estenosis péptica; progresiva con más de 50 años y pérdida de peso → cáncer; intermitente con dolor torácico → espasmo; progresiva con pirosis → esclerodermia; lentamente progresiva con regurgitación → acalasia.

3. Paciente de 40 años con disfagia lentamente progresiva para sólidos y líquidos y regurgitación de alimentos no digeridos. Diagnóstico presuntivo, fisiopatología y estudios.

Diagnóstico presuntivo: disfagia esofágica **motora**, compatible con **acalasia** (es la combinación que, según el profesor, siempre suelen preguntar).

Fisiopatología: se pierde la inervación inhibitoria del plexo mientérico de Auerbach. El cuerpo esofágico deja de contraerse en forma coordinada (aperistalsis) y el esfínter esofágico inferior no se relaja y aumenta su tono. El alimento se retiene, el esófago se dilata y se alarga (dolicomegaesófago) y aparecen regurgitación de alimentos no digeridos y dolor torácico. En nuestro medio hay que preguntar por **enfermedad de Chagas** (acalasia secundaria).

Estudios: esofagograma con bario (esófago dilatado con nivel hidroaéreo y afinamiento distal liso en pico de pájaro o cola de ratón) y **manometría esofágica** (aperistalsis y relajación incompleta del esfínter inferior). **Endoscopía digestiva alta** para descartar un cáncer que imite una acalasia, sobre todo si hay más de 50 años o pérdida de peso.

4. Defina dispepsia según los criterios de Roma, clasifíquela y describa los subtipos de dispepsia funcional.

Definición: dolor o malestar en el abdomen superior (del ombligo hacia arriba) caracterizado por uno o más de: **plenitud posprandial molesta, saciedad precoz, dolor epigástrico o ardor epigástrico**, sin lesión estructural que lo explique (incluida la endoscopía). Los criterios deben estar presentes en los últimos 3 meses, con comienzo al menos 6 meses antes del diagnóstico.

Síndromes de Roma: síndrome de **distrés posprandial** (plenitud y saciedad precoz) y síndrome de **dolor epigástrico** (dolor o ardor localizado, intermitente, que no se alivia con la defecación ni cumple criterios biliares).

Clasificación etiológica: orgánica (≈40 %): úlcera péptica (la más frecuente), ERGE, cáncer gástrico, fármacos (AINEs, antibióticos), diabetes, patología biliar o pancreática. **Funcional**, esencial o no ulcerosa (≈60 %): diagnóstico por exclusión, muy relacionada con el estrés.

Subtipos clínicos de la funcional (clasificación clásica de la clase): tipo reflujo (acidez, regurgitación ácida, pirosis), tipo ulcerosa (dolor que calma con antiácidos y a veces con la comida, puede despertar de noche) y tipo dismotilidad (retortijones que empeoran con la comida).

5. Enumere los signos de alarma en un paciente con dispepsia, explique qué sugiere cada uno y describa la conducta diagnóstica.

Los signos de alarma sugieren una **dispepsia orgánica** y obligan a estudiar el tubo digestivo alto.

- **Edad mayor de 50–55 años**: aumenta la probabilidad de cáncer.
- **Pérdida de peso**: cáncer.
- **Hematemesis**: úlcera u otra causa de hemorragia alta.
- **Vómitos persistentes**: síndrome pilórico.
- **Disfagia u odinofagia progresiva**: cáncer de esófago o de estómago con compromiso del esófago inferior.
- **Ictericia**: patología biliar, pancreática o hepática.
- **Anemia**: cáncer gástrico (déficit de B12 por falta de factor intrínseco; también ferropenia por sangrado).
- **AINEs**, antecedentes familiares de cáncer, cirugía gástrica previa y fracasos terapéuticos.

Conducta: con edad ≥ 55 años o cualquier signo de alarma, **endoscopía digestiva alta con biopsia** (confirma úlcera o cáncer y busca *H. pylori*). En menores de 55 años sin alarma, **prueba de* H. pylori***: si es positiva, erradicación (omeprazol + claritromicina + amoxicilina, "OCA"); si es negativa, inhibidor de la bomba de protones 4–6 semanas y, si fracasa, endoscopía.

6. Explique los mecanismos fisiopatológicos de la dispepsia funcional.

La dispepsia funcional no tiene una lesión estructural: es una alteración de la función gástrica y de su percepción, modulada por el eje cerebro–estómago.

- **Hipersensibilidad visceral**: estímulos normales (una comida, un mate) se perciben como dolor o desencadenan una secreción ácida exagerada.
- **Disminución de la actividad motora gastroduodenal**: el vaciamiento gástrico se retrasa; el contenido retenido distiende el antro y estimula más secreción.
- **Falla de la acomodación fúndica**: el fundus no se relaja al comer → plenitud y saciedad precoz.
- **Reflujo gastroesofágico** por hipersecreción ácida.
- ***Helicobacter pylori***: inflamación de la mucosa sin úlcera.
- **Factores psicológicos** (ansiedad, depresión, somatización, estrés) y **externos** (comidas grasas, intolerancias): actúan sobre el sistema nervioso central y alteran todos los mecanismos anteriores. Son la causa más frecuente.

Así se explican los síntomas: plenitud y saciedad por fallas de acomodación y vaciamiento; dolor y ardor por hipersensibilidad y ácido; distensión, eructos y náuseas por dismotilidad.

7. Clasifique los vómitos según su contenido y su momento de aparición, explicando qué nivel del tubo digestivo o qué causa sugiere cada uno.

Según el contenido (cuanto más procesado, más distal el origen):

- **Alimenticio**: alimentos sin digerir, poco ácidos → esófago.
- **Parcialmente digerido y ácido** → estómago (gastroparesia, obstrucción pilórica, distensión gástrica).
- **Bilioso** (amarillo-verdoso, amargo) → contenido duodenal; patología pancreática, hepática o biliar. Requiere píloro permeable: el síndrome pilórico da vómitos sin bilis.
- **Hemático**: rojo rutilante (sangrado activo) o borra de café (sangre digerida). Origen alto: úlcera, várices, Mallory-Weiss, cáncer.
- **Fecaloide** → obstrucción intestinal baja o fístula gastrocólica.

Según el momento: matinal en ayunas → embarazo, alcohol la noche anterior, hipertensión endocraneana; alrededor de una hora después de comer → estómago; varias horas después → píloro (síndrome pilórico); nocturno → causa orgánica.

Otros datos: el vómito en chorro sin náuseas sugiere hipertensión endocraneana; si el dolor cede al vomitar, úlcera; más de 1.500 ml en 24 horas, organicidad.

8. Describa las complicaciones del vómito y explique el mecanismo de cada una.

Metabólicas. Con el vómito se pierden ácido clorhídrico, agua, sodio y algo de potasio.

- **Alcalosis metabólica**: al perder H^+, el bicarbonato queda en exceso.
- **Hipopotasemia**: parte se pierde con el vómito, pero sobre todo por vía **renal**: la hipovolemia activa la aldosterona (retiene sodio, elimina potasio) y la alcalosis favorece la caliuresis.
- **Deshidratación** e hipovolemia: taquicardia compensadora, hipotensión, oliguria.

Respiratorias. La aspiración del contenido gástrico produce una **neumonitis química** que luego se coloniza (**neumonía aspirativa**); puede causar la muerte.

Mecánicas esofágicas. Mallory-Weiss: los vómitos o arcadas intensas, típicamente en un alcohólico, desgarran la **mucosa** de la unión gastroesofágica → hematemesis. **Boerhaave**: rotura de **todo el espesor** del esófago; el contenido pasa al mediastino (mediastinitis): emergencia.

9. Diferencie náusea, arcada, vómito, regurgitación y rumiación. ¿Por qué importa hacerlo antes de estudiar al paciente?

- **Náusea**: deseo de vomitar.
- **Arcadas**: contracciones rítmicas del abdomen que preceden al vómito, sin expulsión.
- **Vómito**: expulsión activa del contenido gastroduodenal por la boca.
- **Regurgitación**: retorno sin esfuerzo del contenido esofágico o gástrico a la boca, sin náusea ni contracción abdominal.
- **Rumiación**: el contenido vuelve a la boca y el paciente lo traga de nuevo.

Por qué importa: cada fenómeno tiene causas distintas. La regurgitación orienta a patología esofágica (reflujo, acalasia, divertículos) y no tiene las complicaciones del vómito; el vómito activa un reflejo que puede originarse en todo el organismo. Por eso el primer paso del interrogatorio es preguntar si el paciente “lo expulsó” o “le subió solo”.

10. Describa el abordaje del paciente con vómitos: interrogatorio, examen físico y exámenes complementarios iniciales.

Interrogatorio: confirmar que es un vómito (y no regurgitación o rumiación); duración (agudo o crónico); cantidad y frecuencia; náuseas previas; horario (mañana, noche, antes o después de comer); color y sabor; medicación; síntomas acompañantes (dolor y su localización, ictericia, fiebre, diarrea, cefalea, vértigo, pérdida de peso).

Examen físico: signos vitales (taquicardia, hipotensión, temperatura); signos de deshidratación (mucosas, piel, palidez); abdomen (distensión, peristaltismo visible, dolor espontáneo o a la palpación, **chapoteo gástrico** del síndrome pilórico); examen neurológico con **fondo de ojo** (hipertensión endocraneana), signos de Ménière, asterixis y neuropatía autonómica.

Laboratorio: la regla **CEUCGO** (citológico completo, eritrosedimentación, urea, creatinina, glucemia, orina completa) más **ionograma** (hipopotasemia, alcalosis). Según la sospecha: hepatograma, amilasa, albúmina, calcemia y, en mujeres, test de embarazo. **Imágenes y endoscopía** según la etiología sospechada.

Preguntas de repaso (choice)

1. La disfagia orofaríngea también se denomina:
    A. Disfagia baja o de transporte.
    B. Disfagia alta o de transferencia.
    C. Odinofagia.
    D. Globo histérico.
    E. Disfagia paradójica.

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos orienta a una disfagia **orofaríngea**?
    A. Atascamiento retroesternal varios segundos después de tragar.
    B. Regurgitación nasal y tos al intentar tragar.
    C. Disfagia solo para sólidos, progresiva.
    D. Pirosis de larga data.
    E. Dolor torácico intermitente.

3. Según la clase, la causa más frecuente de disfagia orofaríngea es:
    A. Divertículo de Zenker.
    B. Acalasia cricofaríngea.
    C. Accidente cerebrovascular.
    D. Miastenia gravis.
    E. Cáncer de faringe.

4. ¿Qué fase de la deglución es **voluntaria**?
    A. La fase faríngea.
    B. La fase esofágica.
    C. La fase oral (masticación y propulsión del bolo).
    D. La relajación del esfínter esofágico inferior.
    E. Ninguna: toda la deglución es refleja.

5. Paciente que refiere que “traga bien, pero la comida se le traba detrás del esternón”, solo con carne y pan, cada vez peor desde hace tres meses. ¿Qué tipo de disfagia es más probable?
    A. Orofaríngea neuromuscular.
    B. Esofágica motora.
    C. Esofágica mecánica u obstructiva.
    D. Globo histérico.
    E. Odinofagia.

6. Una disfagia esofágica para **sólidos y líquidos desde el inicio**, intermitente e impredecible, sugiere:
    A. Estenosis péptica.
    B. Un trastorno motor esofágico.
    C. Cáncer de esófago.
    D. Anillo de Schatzki.
    E. Compresión por aurícula izquierda dilatada.

7. Según la clase, ¿cuál es la causa más frecuente de disfagia mecánica?
    A. Carcinoma escamoso de esófago.
    B. Estenosis péptica secundaria a la ERGE.
    C. Síndrome de Plummer-Vinson.
    D. Tumor mediastinal.
    E. Divertículo esofágico.

8. Disfagia lentamente progresiva para sólidos y líquidos, con regurgitación de alimentos no digeridos, en un paciente de 38 años de zona endémica de Chagas. El diagnóstico más probable es:
    A. Cáncer de esófago.
    B. Acalasia.
    C. Espasmo esofágico difuso.
    D. Esclerodermia.
    E. Estenosis péptica.

9. En el esofagograma con bario, un **dolicomegaesófago** con afinamiento liso distal “en pico de pájaro” corresponde a:
    A. Cáncer de esófago.
    B. Acalasia.
    C. Espasmo esofágico difuso.
    D. Esofagitis por *Candida*.
    E. Anillo de Schatzki.

10. La imagen en **manzana mordida** en un esofagograma de un paciente de 65 años con pérdida de peso obliga a:
    A. Iniciar inhibidores de bomba y controlar en 6 meses.
    B. Pedir una manometría.
    C. Realizar endoscopía digestiva alta con biopsia.
    D. Indicar dilataciones neumáticas.
    E. Solicitar pHmetría de 24 horas.

11. El estudio que mide el tono y la relajación de los esfínteres esofágicos y caracteriza trastornos como la acalasia es:
    A. La endoscopía digestiva alta.
    B. La manometría esofágica.
    C. La pHmetría de 24 horas.
    D. La tomografía de tórax.
    E. La radiografía simple de tórax.

12. El globo histérico se diferencia de una disfagia verdadera porque:
    A. Siempre se acompaña de pérdida de peso.
    B. Es una sensación de cuerpo extraño en la garganta sin relación con la ingesta.
    C. Empeora progresivamente con sólidos.
    D. Produce regurgitación nasal.
    E. Es dolor al tragar.

13. Según la clase, ¿qué proporción aproximada de las dispepsias es **funcional**?
    A. 10 %
    B. 25 %
    C. 40 %
    D. 60 %
    E. 90 %

14. ¿Cuál de los siguientes **no** es uno de los síntomas que definen la dispepsia según Roma?
    A. Plenitud posprandial molesta.
    B. Saciedad precoz.
    C. Dolor epigástrico.
    D. Ardor epigástrico.
    E. Dolor abdominal que mejora con la defecación.

15. La causa más frecuente de dispepsia **orgánica** es:
    A. Cáncer gástrico.
    B. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
    C. Úlcera péptica.
    D. Pancreatitis crónica.
    E. Antibióticos.

16. ¿Cuál de los siguientes es un **signo de alarma** en un paciente con dispepsia?
    A. Eructos frecuentes.
    B. Plenitud posprandial.
    C. Anemia.
    D. Pirosis ocasional.
    E. Tener 30 años.

17. Mujer de 32 años con dispepsia de 4 meses, sin signos de alarma ni consumo de AINEs. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?
    A. Endoscopía digestiva alta inmediata.
    B. Tomografía de abdomen.
    C. Test no invasivo para *Helicobacter pylori*.
    D. Colonoscopía.
    E. Antibióticos empíricos sin estudiar.

18. En un paciente con cáncer gástrico, el profesor explica la anemia por:
    A. Hemólisis por anticuerpos.
    B. Menor producción de factor intrínseco, con déficit de vitamina B12.
    C. Déficit de eritropoyetina.
    D. Hiperesplenismo.
    E. Exceso de ácido clorhídrico.

19. Un vómito en **borra de café** indica:
    A. Sangrado activo arterial en curso.
    B. Sangre ya digerida por el ácido: sangrado no tan reciente del tubo digestivo alto.
    C. Origen colónico del sangrado.
    D. Várices esofágicas con sangrado masivo.
    E. Vómito fecaloide.

20. Paciente que vomita alimentos ingeridos el día anterior, varias horas después de comer; a la palpación se percibe chapoteo gástrico. ¿Qué sospechás?
    A. Gastroenteritis aguda.
    B. Síndrome pilórico.
    C. Hipertensión endocraneana.
    D. Embarazo.
    E. Acalasia.

21. Vómito **en chorro**, sin náuseas previas, en un paciente con cefalea intensa. ¿Qué tenés que descartar primero?
    A. Enfermedad de Ménière.
    B. Síndrome pilórico.
    C. Hipertensión endocraneana.
    D. Úlcera péptica.
    E. Intoxicación alimentaria.

22. ¿Qué alteración del medio interno es esperable en un paciente con vómitos profusos?
    A. Acidosis metabólica con hiperpotasemia.
    B. Alcalosis metabólica con hipopotasemia.
    C. Acidosis respiratoria.
    D. Alcalosis respiratoria con hiperpotasemia.
    E. Acidosis metabólica con anión gap aumentado.

23. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el síndrome de Mallory-Weiss y el de Boerhaave?
    A. Mallory-Weiss es una rotura transmural.
    B. Mallory-Weiss es un desgarro mucoso de la unión gastroesofágica; Boerhaave, una rotura de todo el espesor del esófago.
    C. Boerhaave ocurre solo en mujeres.
    D. Mallory-Weiss nunca sangra.
    E. Boerhaave produce vómito fecaloide.

24. Para diferenciar un vómito de una regurgitación, el dato más útil es:
    A. El color del contenido.
    B. Que el vómito es un acto activo, con náusea, arcadas y contracción abdominal; la regurgitación ocurre sin esfuerzo.
    C. El volumen expulsado.
    D. El horario.
    E. La presencia de ácido.

25. Paciente con vómitos **biliosos** repetidos. ¿Cuál de estos diagnósticos es **menos** probable?
    A. Obstrucción intestinal por debajo de la papila de Vater.
    B. Colecistitis aguda.
    C. Pancreatitis aguda.
    D. Síndrome pilórico por estenosis del píloro.
    E. Gastroenteritis con vómitos reiterados.

26. Un paciente refiere que “después de vomitar se le calma el dolor de estómago”. El profesor asocia este dato a:
    A. Pancreatitis aguda.
    B. Úlcera.
    C. Cólico biliar.
    D. Apendicitis.
    E. Infarto agudo de miocardio.

27. En la regla **CEUCGO** del profesor, la “C” inicial y la “E” corresponden a:
    A. Creatinina y electrolitos.
    B. Citológico completo (hemograma) y eritrosedimentación.
    C. Calcemia y ecografía.
    D. Colesterol y enzimas hepáticas.
    E. Cultivo y examen de esputo.

28. Varón de 64 años con dispepsia de 2 meses, pérdida de 8 kg y una adenopatía supraclavicular izquierda dura. ¿Qué sugiere y qué estudio pedís?
    A. Linfoma; solo biopsia ganglionar.
    B. Adenocarcinoma gástrico con ganglio de Virchow; endoscopía digestiva alta con biopsias.
    C. Tuberculosis ganglionar; PPD.
    D. Dispepsia funcional; inhibidores de bomba.
    E. Tiroiditis; ecografía tiroidea.

Respuestas

1. **B** — Correcto: falla la **transferencia** del bolo desde la boca hacia la faringe y el esófago superior.
2. **B** — Correcto: fallan los cierres de la nasofaringe y la vía aérea en la fase faríngea.
3. **C** — Correcto: “la número uno de todas”, por lesión de los pares craneales que intervienen en la deglución.
4. **C** — Correcto: es el único de los tres mecanismos que es voluntario.
5. **C** — Correcto: solo sólidos, continua y progresiva.
6. **B** — Correcto: falla el peristaltismo, por eso pasan mal ambos.
7. **B** — Correcto: el reflujo crónico inflama y estrecha el esófago.
8. **B** — Correcto: es la pregunta que “siempre suelen preguntar”; el Chagas es causa de acalasia secundaria.
9. **B** — Correcto: el esófago dilatado termina en un esfínter que no se relaja.
10. **C** — Correcto: confirma el cáncer de esófago.
11. **B** — Correcto: registra las presiones intraluminales.
12. **B** — Correcto: no hay dificultad para el pasaje del alimento.
13. **D** — Correcto: la funcional, esencial o no ulcerosa es la más frecuente.
14. **E** — Correcto: eso orienta al **síndrome de intestino irritable**; el dolor dispéptico no se alivia con la defecación.
15. **C** — Correcto: “la número uno, la que no deben olvidarse”.
16. **C** — Correcto: puede indicar cáncer gástrico o sangrado.
17. **C** — Correcto: estrategia “testear y tratar” en jóvenes sin alarma.
18. **B** — Correcto según la clase; en la práctica también es frecuente la ferropenia por sangrado oculto.
19. **B** — Correcto: es sangre “vieja”.
20. **B** — Correcto: el estómago no se vacía; vómito de retención y chapoteo.
21. **C** — Correcto: estimula directamente el centro del vómito.
22. **B** — Correcto: pérdida de HCl y de potasio (sobre todo renal).
23. **B** — Correcto: por eso Boerhaave produce mediastinitis.
24. **B** — Correcto.
25. **D** — Correcto: si el píloro está obstruido, la bilis no llega al estómago; el vómito es de retención, sin bilis.
26. **B** — Correcto.
27. **B** — Correcto: C-E-U-C-G-O = citológico, eritrosedimentación, urea, creatinina, glucemia, orina.
28. **B** — Correcto: el ganglio supraclavicular izquierdo drena el abdomen superior.